内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·消化性溃疡 & 消化道出血（内科+外科）

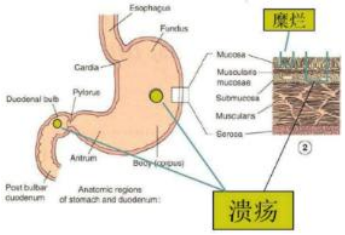
（性感认识：无酸无溃疡、无 Hp 无复发）

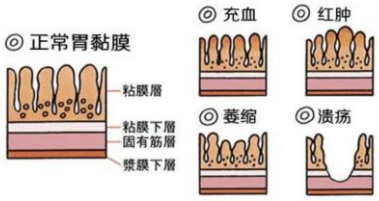
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

不是发生在消化道就叫消化性溃疡 e.g 胃食管反流病-食管黏膜出现糜烂溃疡不叫消化性溃疡
关键是自身消化

一、消化性溃疡概述 攻击因素和防御因素的天平失衡

①消化性溃疡是指胃肠道黏膜被自身分泌的胃酸、胃蛋白酶（主要）、胰酶、胆汁等消化而形成
②消化性溃疡主要为胃溃疡 GU 和十二指肠溃疡 DU，以十二指肠溃疡最常见 十二指肠薄,且球部最先承受胃酸
③消化性溃疡是全球性常见病，各年龄段都可以发生，好发于男性 原因:①胃酸分泌旺盛
②抽烟饮酒损伤胃黏膜屏障





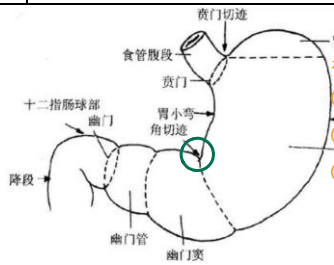
溃疡深达肌层,而粘膜下层有丰富的血管,故消化性溃疡最常见的并发症是上消化道出血

二、消化性溃疡的临床表现

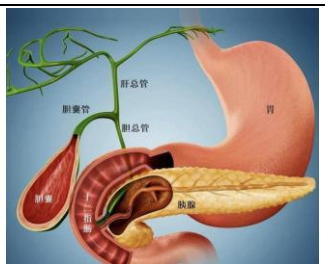
1.**慢性/反复/间断**、周期性/季节性、**节律性**上腹痛 溃疡暴露神经引起腹痛

2.GU VS DU

可能可能最可能	胃溃疡 GU	十二指肠溃疡 DU 迷走N张力高 产生更多酸
节律性上腹痛	**餐后痛（进食→疼痛→缓解）** 餐后分泌胃酸,刺激溃疡面	**饥饿痛（疼痛→进食→缓解）、夜间痛** 餐后食物中和 "饥饿的状态" （青年 12 点容易饿、吃了夜宵就缓解了）
Hp 感染	60-90% 无酸无溃疡,无Hp无复发	>90%（复发率更高）
好发年龄	**中老年**	**青壮年**
好发部位	胃窦小弯侧（胃小弯角切迹/胃角附近） （小老 dou 老胃病）	①HP待在幽门附近球部前壁游离壁,更容易遭受损伤 ②球部立马接受从胃来的酸,承受不了
发病机制	黏膜屏障功能减弱为主 中老年有风湿系统疾病常服用NSAIDs 抑制COX-1致PG↓ 重要的胃粘膜保护因子	侵袭因素增强为主 （DU 患者壁细胞数量增多、对刺激物敏感性增强、迷走神经张力增高、胃排空加快、胃酸分泌反馈抑制机制缺陷→十二指肠球部酸负荷明显增大）精神紧张常为诱因:GC↑→胃酸↑
胃酸分泌	最常见特殊类型 I、IV型：胃酸分泌正常或减少 II、III型：胃酸分泌少量增加	胃酸分泌少量增加 （约占 20-50%） VS胃酸明显增加:胃泌素瘤



精神紧张与很多疾病有关:
①急性糜烂出血性胃炎病因
②肠易激综合征病因
③十二指肠溃疡诱因



胃酸小结:
①胃酸明显减少/缺乏(MAO=0):A型胃炎、胃癌
②胃酸减少:B型胃炎伴大量G细胞丧失
③胃酸正常或减少:B型胃炎、胃溃疡I/IV型
④胃酸增加:十二指肠溃疡、胃溃疡II/III型
⑤胃酸明显增加:胃泌素瘤

I型胃溃疡:胃窦部
II型胃溃疡:胃溃疡+十二指肠溃疡
III型胃溃疡:幽门管溃疡
IV型胃溃疡:高位胃溃疡,胃底胃体

小凯笔记助记图

